

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC)

Guía de información para pacientes y familiares

¿QUÉ ES EL TOC?

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una condición médica caracterizada por dos elementos:

Obsesiones	Compulsiones
Pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos e intrusivos que generan malestar. <i>Son involuntarios y no deseados.</i>	Conductas repetitivas que la persona realiza para reducir la ansiedad generada por las obsesiones. <i>Alivian momentáneamente pero perpetúan el problema.</i>

Afecta al 1-3% de la población. No es una debilidad de carácter — es una enfermedad médica real con tratamiento eficaz.

TIPOS FRECUENTES

Obsesión	Compulsión asociada
Contaminación (gérmenes, suciedad)	Lavado excesivo de manos, limpieza repetitiva
Simetría y orden	Ordenar, contar, repetir hasta que «se sienta bien»
Pensamientos prohibidos (agresivos, sexuales, religiosos)	Rituales mentales, rezar, buscar tranquilización
Miedo a hacer daño a sí mismo o a otros	Verificar cerraduras, gas, electrodomésticos
Miedo a equivocarse	Releer, reescribir, preguntar repetidamente

TRATAMIENTO

El TOC tiene tratamientos con eficacia muy bien establecida. La mayoría de las personas experimenta una mejoría significativa.

Psicoterapia

- La psicoterapia especializada es el tratamiento psicológico con mayor evidencia para el TOC.
- Se basa en enfrentarse gradualmente a las situaciones que generan obsesiones, aprendiendo a tolerar la ansiedad sin realizar la compulsión.
- La ansiedad disminuye de forma natural con el tiempo — aunque en el momento no lo parezca.

Medicación (ISRS)

- Los ISRS son el tratamiento farmacológico de primera línea.
- Se necesitan dosis más altas que en depresión y los efectos tardan 8-12 semanas.
- El tratamiento debe mantenerse al menos 6-12 meses tras la mejoría.
- No suspenda la medicación sin consultar a su médico.

CÓMO FUNCIONA EL CICLO DEL TOC

PENSAMIENTO INTRUSIVO Aparece un pensamiento no deseado	ANSIEDAD El pensamiento genera malestar intenso	COMPULSIÓN Se realiza el ritual para aliviar la ansiedad	ALIVIO TEMPORAL La ansiedad baja... pero el ciclo se refuerza
---	---	--	---

La clave es romper el ciclo: tolerar la ansiedad sin realizar la compulsión. Con el tiempo, el cerebro aprende que la situación no es peligrosa y la ansiedad disminuye sola.

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

Lo que ayuda	Lo que NO ayuda
• Reconocer las obsesiones como síntomas, no como verdades. • No luchar contra los pensamientos — suprimirlos los refuerza. • Tolerar la ansiedad sin ceder a la compulsión. • Mantener rutinas regulares de sueño y actividad.	• Realizar la compulsión «solo esta vez». • Evitar todas las situaciones que generan ansiedad. • Intentar razonar con las obsesiones. • Pedir tranquilización constante a familiares.



Busque ayuda de forma urgente si:

- Los síntomas interfieren gravemente con su vida diaria (trabajo, relaciones, higiene básica).
- Aparecen pensamientos de hacerse daño o de suicidarse.
- Los síntomas empeoran significativamente a pesar del tratamiento.

Línea de Atención a la Conducta Suicida (Ministerio de Sanidad)	024
Urgencias / Psiquiatría de guardia (cualquier hospital público)	112